

Cefaleas

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PRONAP 2012 Módulo 1

La cabeza duele por la activación de receptores nociceptivos ubicados en piel, tejido celular subcutáneo, músculos, vasos sanguíneos, periostio, duramadre, ojos, oídos, senos paranasales y dientes; las vías sensitivas involucradas son los pares craneales V, IX y X, y los nervios del plexo cervical. El parénquima cerebral, el epéndimo, los plexos coroideos, la piamadre y la aracnoides son insensibles al dolor. El dolor tiene además un componente emocional que lo modula, por lo que la magnitud de la percepción es individual en cada paciente.

Clasificación

I. Desde un punto de vista etiológico

Primarias

En las que no hay alteraciones estructurales intra o extracraneanas.

- Migraña.
- Cefalea tensional.
- Cefalea “clúster”.
- Neuralgias de pares craneales y dolor facial de causa central.

Secundarias

Cuando existe una anomalía anatómica.

En este grupo se incluyen: infecciones (sistémicas, del sistema nervioso central, senos paranasales, órbitas, etc.), hemorragias, hipertensión intracraneana, tumores o lesiones expansivas cerebrales

- Traumatismo craneal o cervical.
- Trastornos vasculares craneales o cervicales.
- Trastornos intracraneales no vasculares (infecciones, tumores).
- Uso de drogas o su supresión.
- Infecciones intracraneales o sistémicas.
- Trastornos metabólicos (hipoglucemia, acidosis).
- Dolor facial asociado a trastornos del cráneo, cuello, ojos, orejas, nariz, senos paranasales, dientes, boca u otras estructuras faciales o craneales.
- Trastornos psiquiátricos.

II. Desde un punto de vista evolutivo

Agudas

Cefaleas de una duración inferior a 5 días y sin antecedentes de cefaleas previas.

Según su topografía, pueden ser:

a. Localizadas: cuando tienen una ubicación específica que orienta a su origen.

- Sinusitis
- Otitis
- TEC
- Anomalías oculares
- Afecciones dentarias
- Disfunción mandibular

b. Generalizadas: se extienden a toda la región cráneo-facial.

- Infecciones sistémicas y del SNC
- Fiebre
- Tóxicos (drogas, fármacos, monóxido de carbono)
- Hemorragia intracraneana
- Hipoglucemia
- Hipertensión arterial

Agudas recurrentes

Episodios de presentación periódica, con intervalos libres de síntomas.

- Migraña
- Cefalea tensional episódica
- Hipertensión arterial
- Hidrocefalia intermitente
- Cefalea refleja (tos, ejercicio)
- Hemicránea paroxística nocturna
- Neuralgia trigeminal
- Cefalea relacionada con el síndrome de apnea obstructiva del sueño
- Disfunción témporo-mandibular
- Malformación vascular

Crónicas no progresivas

Cefaleas que duran más de 15-30 días con frecuencia e intensidad de los episodios similares, estables, con ausencia de signos neurológicos anormales.

Se presentan en general por largos períodos y pueden tener diversas causas:

- Cefalea tensional
- Sinusitis crónica
- Trastornos visuales
- Asociadas a trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad
- Post traumatismo craneoencefálico
- Abuso de analgésicos
- Pseudo tumor cerebral

Crónicas progresivas

Cefaleas que duran más de 15-30 días con frecuencia diaria-semanal, con intensidad creciente y presencia de signos neurológicos anómalos.

Pueden ser causadas por:

- Tumores
- Hematoma subdural
- Malformación arterio-venosa
- Hidrocefalia
- Pseudo- tumor cerebral
- Malformación de Arnold Chiari
- Malformación vascular
- Absceso cerebral

Mixtas

Es la combinación en el mismo paciente de varios patrones de cefaleas.

Etiologías

Cefalea aguda	
Frecuentes	Raras
- Infección sistémica. Fiebre - Sinupatía aguda - Meningitis - Síndrome postraumático - Primera crisis de migraña - Cefalea secundaria a punción lumbar	- Encefalitis - Hemorragia subaracnoidea - Hematoma subdural - Hematoma epidural - Glaucoma - Neuritis óptica

Cefalea aguda recurrente	
Frecuentes	Raras
- Migraña - Cefalea tensional episódica	- Hidrocefalia intermitente - Feocromocitoma - Cefalea desencadenada por la tos - Cefalea punzante idiopática - Cefalea agrupada o en racimos - Hemicrania crónica paroxística - Neuralgia del trigémino - Cefalea benigna desencadenada por ejercicio - Colapso ventricular por válvula hiperfuncionante - Cefalea relacionada con el síndrome de apnea obstructiva del sueño
Cefalea crónica	- Abuso de analgésicos - Hematoma subdural - Tumor cerebral - Absceso cerebral - Pseudotumor cerebri - Estado migrañoso - Cefalea tensional crónica

Anamnesis

Antecedentes familiares

- Cefalea
- Epilepsia
- Enfermedades psiquiátricas
- Malformaciones arterio-venosas

Antecedentes personales

- Vómitos y dolores abdominales cíclicos
- Vértigos paroxísticos
- Mareos
- Fiebre recurrente
- Epilepsia
- Cuadros catarrales crónicos
- Traumatismos encéfalo-craneanos
- Cambios de conducta (variaciones en la personalidad, rendimiento escolar, apetito, indagar conflictos familiares).

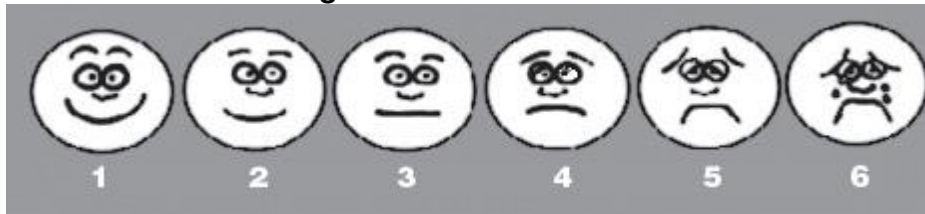
Características de la cefalea

Ubicación

- Localizada
- Generalizada
- hemicraneal

Intensidad

Escala facial de Wong Baker



Sin dolor: 1 | Leve: 2 | Moderado: 3 | Intenso: 4 y 5 | Intolerable: 6

Escala numérica



Sin dolor

Máximo dolor

Conocer la repercusión de la cefalea en la vida diaria del niño o adolescente

En relación a los últimos 3 meses

- Numere los días perdidos de colegio por dolor de cabeza.
- Numere los días perdidos parcialmente de colegio por haber llegado tarde o salido antes por dolor de cabeza.
- Numere los días en los cuales su rendimiento escolar ha estado disminuido por dolor de cabeza.
- Numere los días en los cuales su rendimiento en las tareas de la casa ha estado disminuido por dolor de cabeza.
- Numere los días en los cuales no ha podido participar de actividades recreativas y de deportes por dolor de cabeza.
- Numere los días en los cuales ha podido participar de actividades recreativas y de deportes, pero que su capacidad ha estado disminuida por dolor de cabeza.

Puntuación:

- Igual o menos de 10: compromiso leve.
- De 11 a 20: compromiso moderado.
- Igual o superior a 21: compromiso severo.

Tipo

- Pulsátil
- Punzante
- Opresivo

Irradiaciones

Tiempo de evolución: días, semanas, meses.

Periodicidad: recurrente, constante, imprecisa.

Es de utilidad anotar los episodios en un Registro de Cefaleas

Día	Horario	duración	Intensidad	localización	Síntomas Previos (Aura)	Síntomas acompañantes	Tratamiento Respuesta	Datos complement.

Síntomas acompañantes:

- Náuseas, vómitos
- Fotofobia
- Mareos
- Dolor abdominal y su vínculo temporal con la cefalea (prodrómicos, fase aguda, posterior a la crisis dolorosa).

Horario: nocturno, matutino, vespertino, relación con la escolaridad.

Frecuencia y duración del episodio.**Factores desencadenantes:**

- Ansiedad, depresión, estrés
- Alimentos
 - Cafeína, té, bebidas cola
 - Chocolate
 - Queso maduro
 - Hamburguesas, salchichas
 - Alimentos enlatados, conservantes
 - Aspartamo
 - Frutas secas
- Ejercicio físico intenso
- Ayuno
- Tóxicos (tabaco, alcohol, drogas)
- Frío
- Hipoglucemia
- Privación o exceso de sueño
- Menstruación

Factores agravantes

- Ruido
- Luz
- Frío
- Tos
- Estornudos
- Caminar, subir escaleras.

Factores atenuantes

- Reposo
- Sueño
- Oscuridad

Tratamientos empleados y su eficacia**Examen físico****1. Exploración general**

- Toma de temperatura y presión arterial.
- Aspecto general.
- Piel y anexos (coloración, manchas café con leche, neurofibromas, petequias, todos ellos sospechosos de tumores).
- Semiología cardiopulmonar y abdominal.
- Medición del perímetro cefálico (la circunferencia craneana debe ser medida incluso en niños mayores, dado que el aumento lentamente progresivo de la presión intracraneal causa macrocrania).
- Examen del macizo cráneo-facial: incluyendo percusión (signo de “olla cascada” sugestivo de masa tumoral) y auscultación craneana (soplos o

frémitos sospechosos de malformación arterio venosa). Articulación temporo-mandibular.

- Valoración otorrinolaringológica: puntos sinusales, otoscopia.
- Cuello (columna y musculatura cervicales).

2. Exploración neurológica

- Nivel de conciencia, función intelectual y orientación.
- Marcha y coordinación.
- Pares craneales.
- Tono, fuerza y reflejos musculares profundos.
- Presencia de reflejos patológicos.
- Examen sensitivo.
- Signos cerebelosos.
- Presencia de signos de irritación meníngea o signos neurológicos focales.

3. Exploración oftalmológica

- Agudeza visual.
- Motilidad ocular extrínseca (alineación ocular, presencia de ptosis palpebral).
- Motilidad ocular intrínseca (miosis, midriasis, reflejo fotomotor).
- Campimetría.
- Fondo de ojo.

Métodos complementarios

Pueden solicitarse un laboratorio

- Hemograma
- Glucemia
- Reactantes de fase aguda
- Toxicológico (alcohol, drogas, monóxido de carbono, etc. según sospecha).

La Rx de cráneo y senos paranasales serán requeridas ante la presencia de signos orientadores.

Indicaciones de RNM o TAC

- Cefalea de presentación aguda o hiperaguda.
- Dolor cuya severidad aumenta progresivamente.
- Cefaleas durante el sueño o al despertar.
- Dolor que aumenta con maniobras de Valsalva, ejercicio, tos o cambios posturales.
- Macrocefalia o asimetría craneana.
- Soplo intracraneal.
- Examen neurológico anormal (focalización o déficit, convulsiones).
- Cefaleas refractarias al tratamiento.
- Signos de hipertensión endocraneana.
- Deterioro en el rendimiento escolar, cambios de personalidad, alteraciones en la conducta habitual.
- Cefaleas en portadores de válvulas ventrículo-peritoneales.
- Niño menor de 5 años.

Criterios de ingreso hospitalario

Se decidirá el ingreso ante casos de gravedad real o potencial, o si existe compromiso del estado general. Y en las siguientes situaciones:

- Estado de mal migrañoso.
- Déficit neurológico.
- Infección del Sistema nervioso central.
- Síndrome de hipertensión endocraneana.

- Cefalea intensidad severa y refractaria.
- Traumatismo encéfalo craneano moderado y severo.
- Vómitos incoercibles.
- Migraña hemipléjica.
- Síncopes.

Características según los tipos de cefalea

Migraña

Principal causa de cefalea aguda recurrente.

Más fr en varones antes de los 10 años, invirtiéndose esta relación después de esta edad.

Afecta al 4-8% de los niños entre los 7 y 15 años.

Manifestaciones:

- Cefaleas de intensidad moderada a severa, pulsátil, frecuentemente unilateral
- Se acompaña de dolor abdominal, náuseas o vómitos
- Se agrava con la actividad física
- Interfiere con la vida habitual

Tiene base heredo-familiar, sobre la que actúan factores exógenos diversos como desencadenantes o agravantes de los episodios .

Variantes clínicas

1. Migraña con aura (clásica)

Representa el 5-15% de los casos

El aura consiste en síntomas que preceden a la crisis (de 5 a 60 minutos de duración). Puede manifestarse como:

- Síntomas visuales con características positivas (luces, manchas o líneas parpadeantes), negativas (visión borrosa, escotomas, ceguera transitoria) o ambas.
- Distorsiones del tamaño (micropsias, macropsias) y de la forma metamorfopsias, como en el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas.
- Síntomas sensitivos con características positivas (hormigueo, pinchazos), características negativas (entumecimiento, adormecimiento) o ambas.
- Trastorno del habla disfásico.

2. Migraña sin aura (común)

Es la más frecuente en la infancia (85% de los casos).

Suele ser de localización fronto-temporal y puede ser uni o bilateral.

3. Migraña en racimos (cluster)

Se acompaña síntomas autonómicos:

- Congestión nasal, rinorrea
- Lagrimeo, congestión conjuntival
- Sudación facial
- Miosis, ptosis y edema palpebral

Los ataques aparecen en series que duran de 15 a 180 minutos, repetitivos a lo largo del día, y que se prolongan por semanas a meses separados por otros períodos de remisión.

4. Equivalentes migrañosos

Son síndromes periódicos considerados como precursores migrañosos.

- Vértigo paroxístico benigno
- Migraña abdominal
- Vómitos cíclicos de la infancia

5. Síndromes migrañosos complejos

Se refiere a manifestaciones neurológicas que acompañan a la cefalea, derivadas de la isquemia en áreas puntuales del sistema nervioso central.

Según su localización y su expresión clínica puede hablarse de migraña retiniana, migraña hemipléjica, migraña vertebrobasilar, migraña confusional y migraña oftalmopléjica.

Los síntomas son reversibles cuando cede la crisis.

6. Complicaciones migrañosas

- Infarto cerebral
- Estado de mal migrañoso

Cefalea tensional

Es de presentación frecuente en edad pediátrica y suele asociarse a factores emocionales, por lo que muchas veces una cefalea es un síntoma de un trastorno más profundo.

Características

- Episodios de minutos a días de duración
- De calidad opresiva
- Intensidad de leve a moderada
- Localización bilateral
- No empeora con la actividad física habitual
- No se acompaña de náuseas o vómitos
- Puede presentar fotofobia o fonofobia pero raramente ambas

Según su frecuencia puede dividirse en

- Episódica: menos de 15 por mes
- Crónica: más de 15 mensuales durante 6 meses

Tumor cerebral

Representan la segunda neoplasia más frecuente en la infancia y la primera causa de los tumores sólidos.

Algunos indicios para sospechar esta patología son:

- Cambios en el patrón del dolor (intensidad creciente, localización precisa).
- Alteraciones neurológicas: convulsiones, focalización como trastornos motores o sensitivos, cerebelosos, compromiso de pares craneales.
- Cambios de carácter: apatía, irritabilidad, desatención.
- Compromiso del estado general: anemia, pérdida de peso.
- Asociaciones: déficit hipofisario (polidipsia-poliuria, disminución del crecimiento), patología cutánea (neurofibromatosis, esclerosis tuberosa).

Cuadro clínico de hipertensión intracraneana:

- Dolor agravado por la tos o maniobra de Valsalva.
- Empeora en la mañana o al despertar.
- Se asocia a náuseas y vómitos.
- Alteraciones oculares: disminución de la agudeza visual, diplopía, estrabismo agudo, nistagmus, edema de papila.

Cefaleas de origen oftalmológico

Son poco frecuentes

Están relacionadas con esfuerzos visuales prolongados, por lo que suelen ser vespertinas o nocturnas.

Son cefaleas sordas, leves, opresivas, de ubicación orbitaria o frontal, acompañadas de molestias oculares (visión borrosa, diplopía), que mejoran con el reposo visual o cerrando los ojos.

Cefalea por sinusitis

Asociada a secreción nasal purulenta.

Se localiza sobre el seno paranasal afectado.

Retroorbitaria o en vertex cuando afecta al seno frontal; frente o maxilar superior cuando afecta al seno maxilar; frontal, orbitaria, occipital o en vertex en el seno esfenoidal; y retroocular o temporal en el seno etmoidal.

Cefalea por hemorragia cerebral

En general secundaria a patología vascular congénita (malformación arterio-venosa, aneurisma) o traumatismo cráneo-encefálico.

Es una cefalea de inicio súbito, de intensidad severa (intolerable), con deterioro neurológico rápidamente progresivo.

En el caso de antecedentes familiares de malformaciones vasculares cerebrales o ante la presencia de angiomas cráneo-faciales en un niño se realizarán estudios radiológicos para detección temprana de malformaciones arterio-venosas. La RNM tiene mayor sensibilidad.

Tratamiento

Medidas generales

Cuando se estima un riesgo bajo:

- Dieta equilibrada, evitar ayuno o saltarse comidas, No ingerir alimentos con elevado contenido en glutamato:
 - Cafeína, té, bebidas cola
 - Chocolate
 - Queso maduro
 - Hamburguesas, salchichas
 - Alimentos enlatados, conservantes
 - Aspartamo
 - Frutas secas
- Recreación, actividad física regular
- Manejo adecuado del estrés
- No dormir en exceso o privar del sueño, evitar cambios de horario o alteración del ciclo sueño vigilia.
- Evitar en lo posible si se considera factor desencadenante:
 - Luminosidad excesiva, olores, altitud, cambios climáticos o de presión atmosférica.
 - Ejercicio intenso.
 - Estrés y ansiedad.
 - Fármacos y drogas: anticonceptivos orales, alcohol, drogas (cocaína y anfetaminas producen hemorragia cerebral, heroína es causa de vasculitis en el SNC).
- Medios físicos Frío local, oxígeno 100%, oscuridad, silencio, digito puntura.

Farmacológicas

a) Tratamiento sintomático

Para los dolores leves o moderados se usan analgésicos habituales como

Ibuprofeno

(10 mg/kg c/6-8 hs) o *Paracetamol* (15 mg/kg c/4-6 h); pueden asociarse a cafeína para potenciar su eficacia.

Puede emplearse un antiemético según necesidad; en tal caso se recomienda

Metoclopramida o *Domperidona* a razón de 5-10 mg/kg c/8 horas.

En el caso de cefaleas severas o ante el fracaso de los AINES: fármacos de segunda línea

- *Ergotamina* (1-2 mg/dosis única en mayores de 6 años)
- *Sumatriptan* intranasal (20 mg/dosis en adolescentes con jaqueca).

El estado de mal migrañoso o status migrañoso (cefalea grave de 3 días o más de duración, sin atenuación del dolor con los medios antes referidos) se trata con corticoides (*Dexametasona* o *Prednisona*) y *Fenitoína*, ambos por vía endovenosa y en dosis habituales.

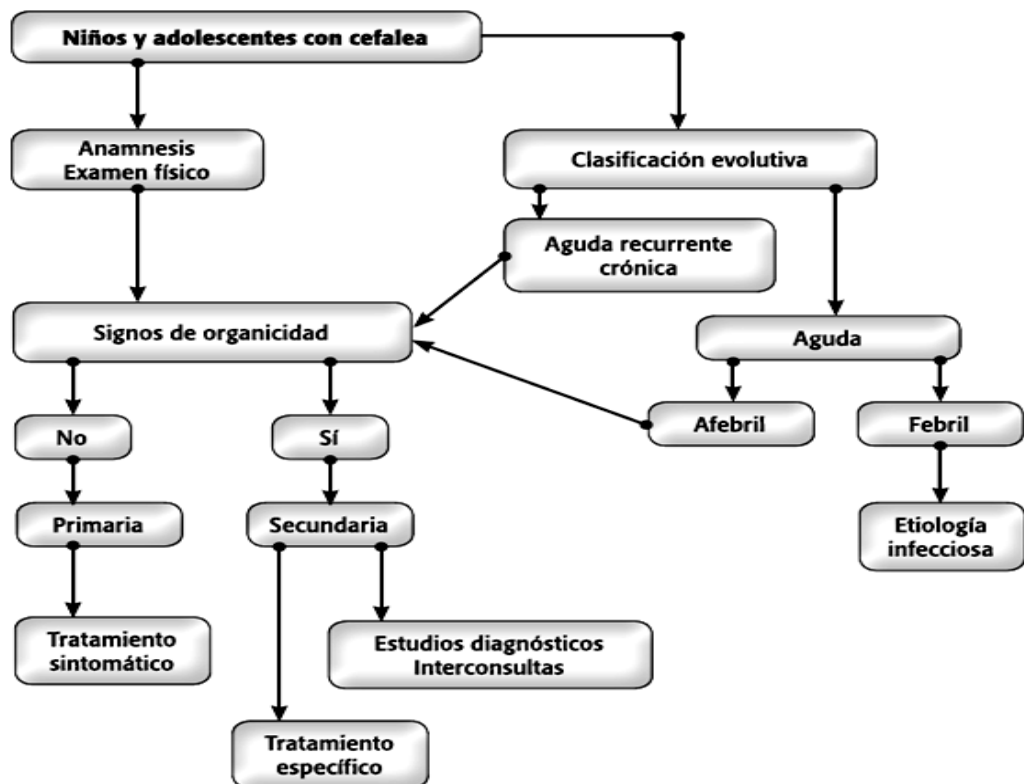
b) Tratamiento profiláctico

Si los episodios migrañosos resultan frecuentes (3-4 al mes por al menos 3 meses) o si se trata de crisis severas con repercusión en actividades de la vida diaria. Comenzar con dosis bajas e ir incrementando gradualmente según tolerancia y efecto; se administrará entre 3 y 12 meses debiendo retirarse de forma gradual a fin de evitar el efecto rebote.

Fármacos

- Flunarizina (5-10 mg/día)
- Propanolol (1-2 mg/kg/día)
- También pueden emplearse ciproheptadina, ácido valproico, amitriptilina, topiramato.

Algoritmo diagnóstico



Instructivo para el paciente

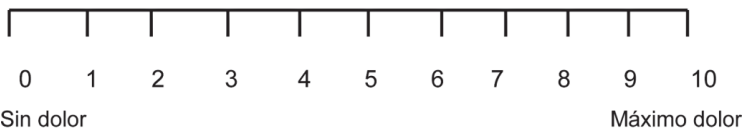
Nombre y Apellido: _____

Edad: _ _ _ _

Fecha de entrega de instructivo: __/__/__

Llenar la siguiente tabla cada vez que padezca dolor de cabeza hasta la próxima consulta.

Tener en cuenta la siguiente escala de intensidad:

[illegible]

En relación a los últimos 3 meses según lo que recuerde:

1. Numere los días perdidos de colegio por dolor de cabeza
2. Numere los días perdidos parcialmente de colegio por haber llegado tarde o salido antes por dolor de cabeza
3. Numere los días en los cuales su rendimiento escolar ha estado disminuido por dolor de cabeza.
4. Numere los días en los cuales su rendimiento en las tareas de la casa ha estado disminuido por dolor de cabeza.
5. Numere los días en los cuales no ha podido participar de actividades recreativas y de deportes por dolor de cabeza.
6. Numere los días en los cuales ha podido participar de actividades recreativas y de deportes, pero que su capacidad ha estado disminuida por dolor de cabeza.